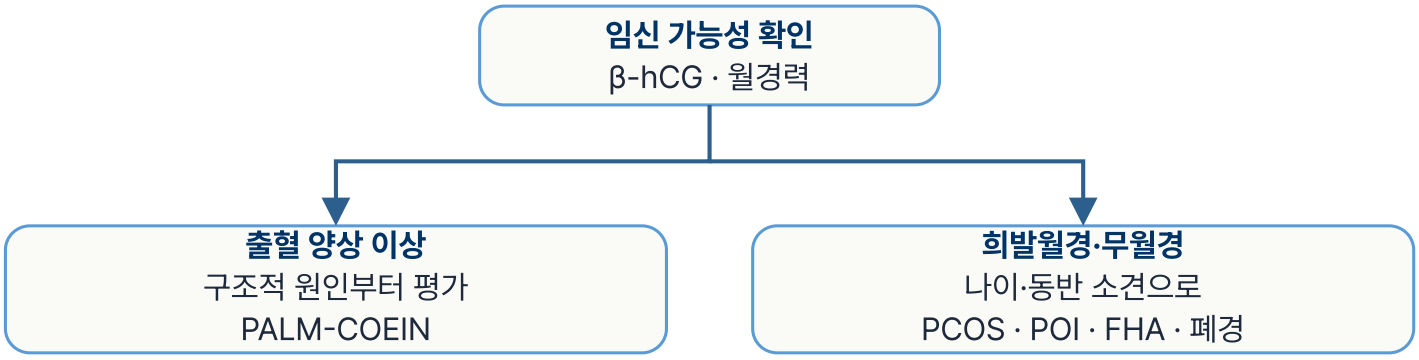
불규칙 월경·무월경 초진에서 의뢰까지

월경력은 전신 건강의 단서 · 가임기에서는 임신 배제가 먼저

먼저 두 경로로 나눕니다



병력과 진찰을 묶어 기록

- ☐ 초경 나이·LMP·최근 **3~6개월**의 주기·기간·출혈량, 산과력·피임법·임신 가능성
- ☐ 체중 변화·만성질환·약물(항응고제·항정신병약 등), 암·조기폐경·출혈성 질환 가족력
- ☐ 활력징후·BMI·갑상선, 유즙분비, 다모증·여드름·남성형 탈모, 복부 종괴·압통

이사라 연자 Q&A · 무월경 상담 — **3개월 이상** 무월경이면 LH·FSH·E2·PRL·TSH 기본 평가와 산부인과 진료를 강조했습니다.

기본검사와 산부인과 연결

내과 초진	산부인과 평가로 연결
β-hCG · CBC · TSH	질경검사: 자궁경부 병변·용종·출혈 부위 양손 골반진찰: 자궁·부속기
소견에 따라 PRL · FSH/LH/E2 Testosterone · DHEA-S · 17-OHP	경질초음파(TVUS) 1차 영상 성경험 없으면 경항문초음파
초경부터 심한 과다월경: Ferritin · 응고검사 · von Willebrand 인자 선별 고려	자궁강 병변: SIS → 자궁경·생검 복잡한 근종·선근증·기형: MRI

의뢰를 앞당길 출혈

폐경 후 출혈 · 성교 후 출혈 · 심한 빈혈 증상

폐경 후 출혈은 **소량·일시적이어도** 자궁내막암을 배제합니다. 어지러움·실신을 동반한 심한 빈혈 증상, 성교 후 출혈은 진찰·검사를 연결합니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · 031-893-4560

출혈 양상과 연령별 기준

초진 상세 ① · 구조적 병변과 청소년·성인 PCOS를 구분

월경 지표는 이렇게 읽습니다

도입부 월경 지표	생애주기표와 청소년기
빈도 **21~35일** · 규칙성 변이 **7~9일** 기간 **2~7일 이내** · 출혈량 **5~80 mL**	생애주기표 성인(18~45세): **24~38일** 초경 후 1~3년: **21~45일**
양은 주관적 평가: 중형 패드를 **2~3시간마다** 교체하거나 매번 밤에 오버나이트 사용 여부 문진	초경 후 3년 이후: **21~35일** 연 **8회 미만** 월경은 희발월경 유방 발달 후 **3년 이내** 초경이 없으면 원발성 무월경 평가

청소년은 초경 후 **1년 이내라도** 월경 간격이 **90일 이상**이면 비정상으로 평가합니다.

AUB: PALM-COEIN

구조적 PALM	비구조적 COEIN
P 용종 · A 선근증 L 근종 · M 악성·증식증	C 응고장애 · O 배란장애 · E 자궁내막 I 의인성·약물성 · N 미분류

암을 놓치지 않는 의뢰

폐경 후 출혈에서 내막 두께가 **4~5 mm 기준을 초과**하면 생검을 고려합니다. 가임기 **45세 이상** 또는 위험인자 동반 불규칙 출혈도 생검 고려. 육안적 자궁경부 병변은 **Pap 결과와 무관하게** 조직생검 의뢰. 용종 제거 후에도 조직학적 확인.

♀ 청소년 PCOS와 성인 PCOS

청소년	성인
월경 불규칙/배란장애와 고안드로겐혈증 **모두** 필요. 초음파 PCOM·AMH는 진단기준에서 제외	배란장애 · 고안드로겐혈증 · PCOM 중 **2/3** + 다른 원인 배제. 성인은 AMH 상승으로 PCOM 대체 가능
한 기준만 있으면 **at risk**로 추적하고 초경 후 **8년** 시점 재평가	갑상선·PRL·비전형 선천성부신과형성·FHA·POI·임신 감별. 쿠싱 표현형이면 24시간 소변 유리코르티솔 등

성인 PCOS의 내과 연결

대사 평가와 생식 목표

연자는 비만 여부와 관계없이 PCOS 의심 환자의 **75g OGTT** 평가를 설명했습니다. 생활습관·체중 관리와 함께 피임·임신 계획을 확인합니다. 강의 증례에서는 피임과 고안드로겐 증상 조절 목적으로 복합경구피임제를 사용했습니다.

무월경: POI · FHA · 폐경

초진 상세 ② · 임신·갑상선·프로락틴과 기질적 원인을 감별

40세 미만 + 폐경 유사 증상

강의의 조기난소부전(POI) 평가

40세 미만 + 희발월경/무월경 **4개월 이상** → FSH **>25 IU/L** → **4주 이상** 간격으로 FSH 상승을 2회 확인하는 경로를 제시했습니다. E2 **<50 pg/mL**는 보조 소견이며 단독 진단기준이 아닙니다. AMH는 1차 검사로 권고하지 않았습니다.

POI 이후의 의뢰 내용

원인 평가	장기 건강·생식 상담
수술·항암·방사선력, 핵형·FMR1 premutation·21-OH 항체, TSH TPO 항체는 POI 진단검사로 권장하지 않음	자연 폐경 연령(약 **50세**)까지 호르몬 치료, 골밀도·심혈관 위험 관리, 생식 상담
TSH: 증상 시 및 **5년 간격** Turner에서 Y 염색체 평가·수술은 전문과 연계	간헐적 배란과 자연임신 가능성은 남아 있음. 가족력이 있으면 가족 상담도 연결

저체중·과운동·스트레스라면 FHA

기능성 시상하부성 무월경은 배제 진단

정상 체중이라도 고강도 운동·에너지 부족이면 고려합니다. 임신·PRL·TSH·PCOS·POI·기질적 원인 배제 후 낮거나 정상 하한 LH/FSH와 저E2를 평가합니다. **두통·시야장애·다뇨·다음**이 동반되면 뇌하수체 MRI. 영양·심리·운동 조절을 연결하고, **6개월 이상** 무월경이면 DXA 평가. 골밀도 저하 시 호르몬 치료를 설명했습니다. FHA에서는 경구복합피임약을 골밀도 개선만을 위한 단독 치료로 권하지 않았습니다.

폐경을 구분하고 다음 진료를 남깁니다

연령·상황	강의의 진단 접근
45세 이상 + 다른 원인 없는 **12개월** 연속 무월경	전형적 증상이면 호르몬 검사 없이 임상 진단
40~45세 폐경 증상·주기 변화 / **40세 미만**	호르몬 평가 고려 / POI 평가로 전환
호르몬 피임제·호르몬 IUD 사용 중	출혈 패턴만으로 폐경 판단하지 않음. 이행기 FSH 단회로 확정하지 않으며 피임 상담 병행